Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Quaraí

Rua Dr. Acauan, 320 - Bairro: Centro - CEP: 97560000 - Fone: (55) 3029-9973 - Email: frquaraivjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001127-05.2021.8.21.0061/RS

AUTOR: ENI PINTO LAMEGO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

ENI PINTO LAMEGO ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, ao argumento de que estava internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, diagnosticada com REESTENOSE AÓRTICA GRAVE - CID - 10: I-350, apresentando insuficiência cardíaca classe IV, descompensada com componente broncoespasmo, dispneia e anemia microcítica, hipocrômica e ferropênica, além de doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC com diversos edemas agudos (Euroscore II de 62,64%) - CID. I35. Sustentou que necessitava, com a máxima urgência, da realização de tratamento intervencionista da Estenose Aórtica, consoante prescrição médica, sendo recomendado o implante transcatéter de prótese de válvula aórtica (TAVI) como única solução, considerando que a cirurgia convencional não era possível face as comorbidades e a fragilidade do seu estado de saúde. Referiu que, por meio da administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS, solicitou junto ao IPERGS autorização para realizar o procedimento em questão, bem como dos materiais necessários indicados na "solicitação de materiais especiais" e na "solicitação complementar de materiais", entretanto, foi indeferida pelo seguinte motivo: "material sem cobertura pelo IPE-SAUDE e sem previsão orçamentária para inclusão na TOPME". No entanto, sustentou que não poderia sofrer a violação do seu direito de ter custeado pelo IPE Saúde o tratamento médico que necessitava, porquanto a Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018 e a Resolução nº 21/79 preveem que serão cobertos pelo IPE Saúde os "atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos". Pontuou ter sido a segunda vez que necessitava passar por este procedimento e que na primeira oportunidade também teve que recorrer ao Poder Judiciário, em face da negativa do requerido. Salientou não possuir condições financeiras para arcar com o custo do tratamento indicado. Pediu, em tutela de urgência, que fosse determinado ao réu que autorizasse e custeasse imediatamente o procedimento para implantação da prótese valvar aórtica transcatéter (TAVI) Edwards Sapiens 3 nº 26, nos termos em que descrito pelo seu médico assistente, bem como de todos os materiais descritos nas Solicitações de Materiais Especiais e outros que se fizessem necessários para o pré, durante e pós intervenção, inclusive medicamentos, sob pena de bloqueio dos valores necessários a tanto. Ao final, a procedência da ação, confirmando-se a tutela de urgência. Com a inicial, juntou documentos (Evento 1).

Concedida a liminar (Evento 4, DESPADEC1).

Noticiado o cumprimento da tutela de urgência (Evento 18).

O réu interpôs AI (Evento 25), que foi provido para substituir a multa diária pelo bloqueio de valores (Evento 74).

Sobreveio petição da autora, pugnando que fosse determinado o bloqueio do valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) nas contas bancárias do réu, com o fim de adimplir os honorários dos profissionais médicos que realizaram o seu procedimento, bem como fosse reconhecido que o pagamento dos materiais que lhe estavam sendo cobrados se encontravam abrangidos pela decisão liminar, independentemente de não possuírem cobertura na tabela do IPERGS (Evento 38, PET1).

O réu contestou no Evento 39, CONT1, alegando, em síntese, que não poderia ser compelido à cobertura de um tratamento que excedia o previsto por seu regulamento, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Referiu que o sistema do IPÊ-SAÚDE tem sua cobertura definida pelas leis, decretos e normativas institucionais, nos termos dos artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual n. 15.145/2018, e esclareceu que a referida lei exclui, expressamente, todos os tratamentos que não estiverem previstos nas tabelas próprias do Instituto, nos termos do art. 4º, § 1º. Pontuou que por se tratar de órgão público, a contribuição ao IPERGS somente pode ser alterada por lei (art. 37 CF), ou seja, a adequação do Instituto aos seus gastos somente poderá ser feita mediante o processo legislativo regular, não competindo ao Poder Judiciário invadir esfera restrita ao administrador (art. 2º da CF), pois ao interferir nas regras estabelecidas por ele em plano de saúde restrito aos seus servidores estaduais, acabava por abalar os princípios da igualdade, da legalidade e da independência e harmonia dos poderes previstos pela Carta Magna em seus arts. 2º, 5º, *caput*, e 37. Pugnou pela improcedência. Em eventual condenação, postulou fosse considerada a obrigação relativa à coparticipação financeira do usuário, de acordo com a categoria a que estava enquadrada a autora.

Novo pedido de bloqueio, por parte da autora, para o fim de adimplir com os honorários dos profissionais médicos que realizaram o seu procedimento (Evento 41, PET1). O pleito foi deferido pelo juízo (Evento 44, DESPADEC1).

O réu opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão que deferiu o bloqueio de valores, na medida em que o pagamento de honorários médicos e demais materiais utilizados no procedimento cirúrgico a que havia se submetido a parte autora eram pontos controvertidos em sede de agravo de instrumento, que ainda pendia de julgamento pelo Tribunal e, caso fosse provido, ficaria sem utilidade prática alguma (Evento 49, EMBDECL1).

Contrarrazões dos embargos pela parte autora (Evento 63, PET1).

Os embargos foram rejeitados, porém foi determinada a suspensão da decisão que determinou a expedição de alvará em favor da parte autora até o julgamento do AI (Evento 64, DESPADEC1).

Réplica (Evento 69, RÉPLICA1).

Acostado pedido de tutela de urgência incidental, por parte da requerente, para o fim de determinar a expedição de alvará dos valores bloqueados (Evento 72, PET1).

Diante do julgamento do AI, foi deferida a expedição dos alvarás (Evento 75, DESPADEC1).

Intimadas as partes para dizer sobre o interesse na dilação probatória (Evento 87, DESPADEC1), informaram não possuir provas a produzir (Evento 91, PET1 e Evento 93, PET1).

Vieram os autos conclusos para a sentença.

É o relato. Decido.

No caso, a controvérsia cinge-se ao fato de que o tratamento pleiteado pela autora não estaria previsto na cobertura do plano de saúde, tampouco existiria previsão de inclusão na TOPME.

O art. 2º da Lei Complementar nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79, que Regulamenta a Assistência Médico-Hospitalar do IPERGS, estabelecem que o Plano IPE-SAÚDE abrange os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Como se vê, a abrangência do plano é bastante ampla.

Ainda que não se desconheça o teor do art. 4º, § 1°, da Lei Estadual nº 15.145/2018[1], no sentido de que ficariam excluídos da cobertura os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais que não estivessem previstos nas tabelas próprias do Instituto, o e. STJ já se manifestou a respeito da questão, entendendo que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamentos. *Verbis*:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais. 2.* ***O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017)*** *3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.739.747 - SP, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, Julgado em 16 de outubro de 2018).*

Tal entendimento se dá principalmente porque é o profissional que acompanha o paciente que detém as melhores condições para o correto diagnóstico e a correlata prescrição de tratamento, devendo a sua indicação ter prevalência, em atendimento ao direito constitucional à saúde.

Dessa forma, mostra-se irrelevante o fato de o plano de saúde ser na modalidade privada ou de autogestão, pois este se obriga a cobrir todo o tratamento necessário para as especialidades a que se propõe dar cobertura, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que exclua alguma espécie de tratamento.

Conforme art. 8° da Resolução n° 21/79, a especialidade cardiologia está coberta pelo plano de saúde para o qual a autora contribui e, como já referido, a cobertura se dá em razão da enfermidade, não podendo haver restrição quanto ao tratamento.

No mesmo sentido, a jurisprudência do e. TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE SAÚDE. IPÊ-SAÚDE. VALVOPLASTIA PERCUTÂNEA POR VIA TRANSEPTAL - IMPLANTAÇÃO DE CLIPE MITRAL. NEGATIVA DO IPERGS. NÃO CABIMENTO. Parte, internado no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo diagnosticado com insuficiência mitral grave, insuficiência cardíaca esquerda, insuficiência renal, cardiopatia isquêmica e hipertensão arterial sistêmica com alto risco cirúrgico a quem indicado valvoplastia percutânea por via transeptal - implantação de clipe mitral (Sistema Mitralclip). Indicação por médicos, que expressamente justificaram a urgência e o risco de realização do procedimento pelo menor risco.* ***O segurado do IPE-SAÚDE tem direito ao recebimento de tratamentos indispensáveis, no caso, às suas graves moléstias, uma vez que a especialidade cardiologia está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. Deve, assim, receber a terapêutica adequada para a sua enfermidade. A falta de contemplação na Tabela do IPERGS não pode prevalecer ante indicação precisa em sentido contrário partida de diversos profissionais especializados que assistiam ao segurado.*** *TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. Em ação proposta após a vigência da Lei Estadual nº 14.634/2014, não se mostra cabível o pagamento de custas processuais pela autarquia, salvo o que disser com reembolso à parte vencedora (parágrafo único do artigo 5º) pelo que antecipou para estar em juízo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tratando-se de demanda em que visada exclusivamente a obtenção de proveito econômico, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.850.512/SP. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50067215920168210001, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 16-11-2022).*
>
> *APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO - FECHAMENTO PERCUTÂNEO DO FORAME OVAL PATENTE (FOP) – E MATERIAIS CIRÚRGICOS. DEMANDANTE PORTADORA DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID 10 G 45 (ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUÊMICOS). NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA PROCEDIMENTO E*

MATERIAIS CIRÚRGICOS CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E HARMONIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. Descabe conhecer da remessa necessária, em face da ausência de dimensão econômica do comando sentencial. 2. Tendo em vista a amplitude de cobertura definida no art. 2º da LC nº 12.134/04, atrelada às disposições da Resolução nº 21/1979, o critério utilizado pela Administração Pública para definição dos serviços oferecidos pelo IPÊ-Saúde é o da exclusão expressa, de modo que, em princípio, todos os serviços de tratamento hospitalar ou ambulatorial curativos são custeados, exceto os expressamente excluídos. 3. Hipótese em que a equipe médica que assiste a demandante prescreveu a realização de procedimento cirúrgico de Fechamento Percutâneo do Forame Oval Patente (FOP). ***A cobertura do plano de saúde ao procedimento cirúrgico há de ser reconhecida, tendo em vista que o procedimento está inegavelmente inserido nas especialidades Cardiologia e Angiologia, inexistindo vedação expressa do seu custeio. 4. Ainda que assim não fosse, resta o registro de que não cabe ao Plano de Saúde selecionar o tipo de tratamento que será coberto. Ou seja, assim como ocorre nos Planos de Saúde de natureza privada, se há previsão contratual de cobertura da patologia, não cabe ao Plano de Saúde selecionar o tipo de tratamento que terá ou não cobertura.*** *5. Não podem prosperar os argumentos referentes ao prejuízo orçamentário e à violação dos princípios da isonomia, igualdade e harmonia dos poderes, porquanto a patologia da qual padece a parte autora e o procedimento postulado estão cobertos pelo plano de saúde contratado. 6. Isenção das custas processuais. Aplicabilidade das disposições contidas na Lei Estadual nº 14.634/2014, que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais. 7. Inadequada a fixação de verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa quando o valor da condenação for devidamente mensurado. Merece guarida, portanto, a insurgência da demandante quando sustenta o cabimento de condenação ao pagamento de verba honorária em quantia correspondente a, no mínimo, 10% sobre o valor da condenação, em observância ao que determina o artigo 85,§3º, I, do CPC/2015. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO IPERGS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA DEMANDANTE PROVIDO.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70078958402, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 14-11-2018).*

Em relação à alegação de que o Poder Judiciário estaria invadindo esfera restrita ao administrador, não assiste razão o demandado. Isso porque, o tratamento foi solicitado e negado pela via administrativa, surgindo, assim, a pretensão autoral em buscar o bem almejado, direito de ação garantido constitucionalmente (art. 5º, inc. XXXV), cumprindo ao Judiciário a aplicação e interpretação do sistema jurídico sempre que instado.

Superadas as questões e comprovado que o procedimento pleiteado era imprescindível ao caso da autora, diante do laudo médico aportado (Evento 1, LAUDO4), e havendo cobertura no plano de saúde para a especialidade, não sendo cabível qualquer restrição de tratamento, é o caso de procedência da ação.

No que concerne ao pleito do réu para que seja observada a coparticipação do usuário, diante do que dispõe o § 1° do art. 2º da Lei Estadual nº 15.145/2018, não merece acolhimento.

Isso porque, o art. 30 da legislação supra regulamenta as hipóteses de coparticipação financeira, excepcionando, contudo, os casos de internações hospitalares e tratamentos ambulatoriais:

Art. 30. O usuário do Sistema IPE Saúde realizará o pagamento de parte das despesas com consultas, exames complementares, serviços ou procedimentos, a título de coparticipação, em percentual de até 40% (quarenta por cento) do valor constante de tabelas de procedimentos adotadas do IPE Saúde, conforme estabelecido em regulamento específico.

Parágrafo único. É vedada a coparticipação dos usuários nas internações hospitalares e tratamentos ambulatoriais.

No caso dos autos, incide a exceção prevista no parágrafo único do aludido diploma, vez que a autora foi diagnosticada quando de sua internação e a cirurgia foi realizada em ambiente hospitalar, incluindo-se na cobertura, por obvio, os materiais nela utilizados.

Nesse sentido, assim já decidiu o TJ-RS em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR Nº 15.145/2018. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO NA ORIGEM. ÓBITO DA AUTORA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANEURISMA DE AORTA TORÁCICO-ABDMONIAL. PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE ENDOPRÓTESES E TRÊS STENTS. CIRURGIA REALIZADA EM AMBIENTE HOSPITALAR. AUSENTE COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. (...) 3. Até o advento da novel legislação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, restava praticamente tranquila a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de coparticipação financeira do segurado tão somente quanto a exames e consultas com fundamento na Resolução nº 311/2000. Todavia, segundo o artigo 30 da Lei Complementar nº 15.145/2018, restaram ampliadas as hipóteses de coparticipação para além das consultas e exames, abarcando serviços ou procedimentos, com base no valor constante de tabelas de procedimentos adotadas pelo IPE Saúde, ***vedada a cobrança nos casos de internações hospitalares e tratamentos ambulatoriais. In casu, incidente a exceção do art. 30, parágrafo único, da Lei Complementar nº 15.145/2018, eis que se trata de cirurgia realizada em ambiente hospitalar, inexistindo hipótese de coparticipação em caso de internação hospitalar, como no caso. A coparticipação existiria caso se tratasse de procedimento realizado fora do hospital.*** *(...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(excerto do Agravo de Instrumento, Nº 50837532220218217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-01-2022)*

Alia-se a isso o teor dos arts. 11 e 12 da Resolução nº 21/79, os quais dispõem que, em casos cirúrgicos, a cobertura é integral:

Artº 11 – Considera-se Emergência Médica:

a) os casos clínicos agudos ou mesmo crônicos mas que a qualquer momento ponham risco a vida do beneficiário;

b) ***os casos cirúrgicos*** *ou traumatológicos agudos;*

c) demais acidentes (evento violento e externo).

*<u>**Artº 12 – Será integral a cobertura nos casos referidos no artigo anterior letras "b" e "c"**</u>, e de 50% nos casos referidos na letra "a". (grifei).*

Dessa forma, não há que se falar em coparticipação financeira no caso.

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **ENI PINTO LAMEGO** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL** para condená-lo à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o procedimento para implantação da prótese valvar aórtica transcatéter (TAVI) Edwards Sapiens 3 nº 26, nos termos prescritos pelos médicos que acompanham a autora, bem como de todos os materiais descritos nas Solicitações de Materiais Especiais e de outros que se mostrarem necessários para a cirurgia e também para as fases pré e pós-cirúrgica, inclusive medicamentos, confirmando a liminar concedida no Evento 4, DESPADEC1.

O réu é isento de custas. Condeno-o, no entanto, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 2°, 3° e 4°, inc. III, do CPC, por se tratar de demanda singela, sob o ponto de vista jurídico, com jurisprudência praticamente consolidada sobre a questão posta.

P. R. I.

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte apelada para contrarrazões, no prazo legal. Após, ao TJRS para julgamento do recurso.

Com o trânsito, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **EVERTON PADILHA SOARES, Juiz de Direito**, em 19/3/2023, às 21:13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10034734966v109** e o código CRC **2322fea7**.

---

1. Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto. ↩